

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI DỰ THI OLYMPIC KHỞI NGHIỆP 2026

Tên dự án: HOMACARE - NỀN TẢNG KẾT NỐI VÀ ĐIỀU PHỐI DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NHÀ

Thuộc lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội

Nhóm thực hiện

Nguyễn Tiến Anh : 11241299

Phạm Hiền Minh : 11241443

Đỗ Thủy Ngọc : 11246350

Nguyễn Minh Hiếu : 11241367

Trần Thị Minh Anh : 11241310

Hà Nội, Tháng 09/2026

TÓM TẮT DỰ ÁN:

- Tên dự án: HOMACARE - Nền tảng kết nối và điều phối dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà
- Ý tưởng chính của dự án: HOMACARE kết nối người thân ở xa với người chăm sóc đáng tin cậy tại địa phương, giúp gia đình có thể chăm sóc và theo dõi cha mẹ từ xa.
- Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án: HOMACARE là nền tảng kết nối và điều phối dịch vụ chăm sóc người cao tuổi với Chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia, hỗ trợ con cái sắp xếp và theo dõi quá trình chăm sóc cha mẹ từ xa. Qua đó, cha mẹ được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn duy trì sự tự chủ, đồng thời người con có thể an tâm đồng hành dù không thể trực tiếp ở bên.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

1. Tổng quan dự án

ĐỐI TÁC CHÍNH	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ	QUAN HỆ KHÁCH HÀNG	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
- Cơ sở đào tạo y tế (Đại học Y Hà Nội, Đại học Điều dưỡng Nam Định, CĐ Y tế địa phương). - Hội Người cao tuổi và các trạm y tế phường/xã. - Cơ sở y tế chuyên khoa - Các doanh nghiệp bảo hiểm. - Đơn vị tư vấn pháp lý (cho khách hàng, người lao động và doanh nghiệp). - Quỹ đầu tư tác động xã hội và các vườn ươm khởi	- Tuyển chọn, xác minh nhân thân và đào tạo 30 giờ chuẩn hóa. - Đánh giá nhu cầu và thiết kế kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa. - Điều phối ca làm việc của người lao động, kiểm tra thời gian thực khi giao nhận ca. - Quản lý pháp lý trong quá trình vận hành nền tảng và tuân thủ bảo mật dữ liệu.	- Cho con cái (Người mua): - Mua sự an tâm, sự có mặt gián tiếp qua các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, giải tỏa lo lắng và áy náy khi ở xa. - Theo dõi minh bạch từ xa qua Bảng quản lý chăm sóc được hiện diện trên nền tảng và minh chứng nhật ký sau mỗi ngày chăm sóc. - Mạng lưới	- Khảo sát, tư vấn cá nhân hóa một - một qua Điều phối viên chăm sóc. - Tự phục vụ minh bạch qua ứng dụng, bảng quản lý chăm sóc gia đình. - Báo cáo nhật ký và xác nhận tức thì sau mỗi ca làm việc. - Tích điểm thưởng, phiếu giảm giá và chương trình giới thiệu.	- Người mua dịch vụ: Con cái từ 35 đến 45 tuổi, thu nhập ổn định, làm việc xa cha mẹ tại đô thị lớn. - Người sử dụng dịch vụ: Người cao tuổi từ 65 đến 75 tuổi, đang mắc/có nguy cơ mắc các bệnh suy giảm một phần chức năng sinh hoạt. - Địa bàn thí điểm: Một quận mật độ

nghiệp trong nước.	TÀI NGUYÊN CHÍNH - Đội ngũ Điều phối viên chăm sóc và Quản lý cụm địa phương. - Nền tảng Bảng quản lý chăm sóc gia đình và ứng dụng đặt lịch. - Bộ quy trình tuyển chọn, xác minh và khung đào tạo 30 giờ. - Cơ sở dữ liệu chăm sóc và uy tín thương hiệu tích lũy.	chuyên viên uy tín, Điều phối viên hỗ trợ 24/7. Cho người cao tuổi (Người dùng): - An dưỡng tại nhà trong không gian quen thuộc, giữ sự tự chủ. - Chăm sóc phi y tế tận tâm, không thay thế thủ thuật y tế. - Hỗ trợ liên lạc các cơ sở y tế trong các trường hợp khẩn cấp	CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHẢN HỒI - Kênh trực tuyến: Website, Facebook, TikTok, Zalo chính thức. - Kênh cộng đồng: Hội Người cao tuổi, Trạm y tế phường/xã. - Kênh liên kết: Bệnh viện, phòng khám, cơ sở chuyên khoa. - Phân phối trực tiếp: Chuyên viên chăm sóc tận nhà.	dân cư cao tại Hà Nội trong 6 - 12 tháng đầu.
CẤU TRÚC CHI PHÍ - Biến phí thù lao: Trả 78% tổng giá trị giao dịch cho chuyên viên chăm sóc. - Chi phí đào tạo: 800.000 đến 1.200.000 đồng/chuyên viên cho khóa 30 giờ.			DÒNG DOANH THU - Doanh thu thuần nền tảng: Phí chiết khấu 22% trên tổng giá trị giao dịch.	

- Chi phí nhân sự bộ máy: Lương quản lý địa phương (10 đến 12 triệu đồng/tháng). - Chi phí công nghệ, tiếp thị IMC, bảo vệ dữ liệu và bảo hiểm trách nhiệm.	- Các dịch vụ chăm sóc, các gói hỗ trợ dành cho người cao tuổi.
--	---

2. Mô tả chi tiết về sản phẩm/dịch vụ

2.1. Tính cần thiết

2.1.1. Giai đoạn phát triển của sản phẩm/dịch vụ

HOMACARE hiện vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng và phát triển mô hình thử nghiệm. Dự án chưa triển khai thương mại trên quy mô lớn mà tập trung xây dựng phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu để kiểm chứng nhu cầu thị trường, khả năng vận hành và mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng. Giai đoạn thử nghiệm dự kiến được triển khai trong 6 - 12 tháng với phạm vi ngân sách giới hạn, tại một khu vực cụ thể ở Hà Nội. Sản phẩm được định hướng là nền tảng kết nối, điều phối và theo dõi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, kết nối người thân ở xa với chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia - người hỗ trợ chăm sóc tại địa phương.

2.1.2. Mục tiêu, giá trị và tiềm năng

a. Mục tiêu

HOMACARE hướng tới giải quyết vấn đề con cái không thể thường xuyên ở bên cha mẹ vì sự giới hạn về mặt thời gian, địa lý nhưng vẫn muốn duy trì vai trò chăm sóc và nắm bắt tình hình của cha mẹ. Dự án tập trung vào các mục tiêu:

- Kết nối người cao tuổi với chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia phù hợp và đáng tin cậy tại địa phương.
- Hỗ trợ gia đình sắp xếp và điều phối các hoạt động chăm sóc.
- Cho phép người thân theo dõi quá trình chăm sóc từ xa thông qua lịch chăm sóc, ghi nhận và cập nhật sau mỗi lần thực hiện.
- Xây dựng mô hình chăm sóc tại nhà có thể triển khai thử nghiệm và từng bước mở rộng.

b. Giá trị

- Đối với người thân: giảm sự lo lắng, căng thẳng khi không thể trực tiếp chăm sóc, đồng thời tăng khả năng theo dõi và chủ động trong quá trình chăm sóc cha mẹ.
- Đối với người cao tuổi: được hỗ trợ trong các hoạt động hằng ngày, có thêm sự đồng hành nhưng vẫn có thể duy trì cuộc sống tại nhà và sự tự chủ.

- Đối với Chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia: tạo cơ hội cung cấp dịch vụ chăm sóc tại địa phương trong một mô hình có quy trình tuyển chọn, điều phối và đánh giá rõ ràng.

- Slogan: HOMACARE - Gửi trọn quan tâm, vẹn tròn đạo hiếu

c. **Tiềm năng**

Một nghiên cứu của hai TS. Phí Mạnh Phong & Phí Mạnh Hồng vào năm 2022 đã chỉ ra rằng từ bao đời nay, việc phụng dưỡng người già ở Việt Nam vẫn được xem là bổn phận gắn liền với mái ấm gia đình, cha mẹ về già có vợ/chồng, con cháu kề cận chăm nom. Nhưng bức tranh ấy đang dần đổi khác khi gia đình ngày càng có ít con, người trẻ rời quê lên phố hoặc bươn chải mưu sinh nên chẳng còn mấy thời gian ở bên cha mẹ, chưa kể quan niệm về việc các thế hệ có nên sống chung một mái nhà hay không cũng đã thay đổi nhiều so với trước. Tuy nhiên, phần lớn người cao tuổi, đến những năm tháng cuối đời, vẫn chỉ mong được quanh quẩn bên gia đình, xóm giềng thân thuộc chứ không muốn xa rời. Rồi cũng phải kể đến bài toán tiền bạc: không nhiều gia đình đủ khả năng gánh chi phí cho các viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc tập trung, nên tất yếu phải tìm ra một hướng đi khác phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế của họ. Tất cả những điều đó cộng lại khiến chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi trở thành một trong những nút thắt lớn của quá trình già hóa dân số mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Những thay đổi này tạo ra một khoảng trống rõ rệt giữa nhu cầu được chăm sóc của người cao tuổi và khả năng trực tiếp chăm sóc của con cái, qua đó hình thành nhu cầu đối với các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà có tổ chức. Đáp ứng nhu cầu đó, HOMACARE được xây dựng theo mô hình kết nối và điều phối Chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia, tạo cơ sở để phát triển từ phạm vi chăm sóc tại một khu vực giới hạn thành mạng lưới tại nhiều địa phương Về dài hạn, mô hình có thể mở rộng các gói chăm sóc định kỳ và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng gia đình.

2.1.3. *Đối tượng khách hàng quan trọng và lý do lựa chọn*

HOMACARE phân biệt rõ giữa người mua và người sử dụng sản phẩm:

Tiêu chí	Người mua	Người sử dụng
Đối tượng	Con cái/người thân của người cao tuổi	Người cao tuổi
Độ tuổi	Khoảng 35 - 45 tuổi	Khoảng 65 - 75 tuổi
Đặc điểm	Đi làm, đã lập gia đình, thu nhập tương đối ổn định ở mức trên 30 triệu	Có khả năng nhận thức, giao tiếp và sinh hoạt tương đối độc lập; chỉ hạn chế nhẹ về

	VNĐ/tháng/người, sinh sống xa gia đình	vận động hoặc một số chức năng cơ thể.
Bối cảnh	Muốn chăm sóc cha mẹ nhưng bị giới hạn bởi khoảng cách và thời gian	Sống tại nhà, cần hỗ trợ hoạt động thường ngày trong cuộc sống
Nỗi đau	Ở xa, không thể trực tiếp chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của cha mẹ; đồng thời khó tìm được người chăm sóc đáng tin cậy.	Không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hoặc phải chuyển khỏi nhà
Tiêu chí lựa chọn dịch vụ	Độ tin cậy của người chăm sóc, mức độ minh bạch thông tin, khả năng theo dõi từ xa, sự ổn định của dịch vụ và chi phí hợp lý	Người chăm sóc phù hợp, thái độ tốt, tôn trọng thói quen cá nhân và khả năng hỗ trợ ngay tại nhà
Giá trị HOMACARE mang lại	Sự yên tâm và khả năng theo dõi từ xa	Sự hỗ trợ tại nhà và duy trì tính tự chủ
Vai trò trong quyết định	Người quyết định và chi trả	Người trực tiếp sử dụng và ảnh hưởng đến quyết định sử dụng

Bảng 1: Chân dung khách hàng mục tiêu

a. Vì sao lựa chọn nhóm khách hàng này?

Dựa trên dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu sức khỏe cộng đồng cho thấy Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên tính đến năm 2024, dự kiến đạt gần 18 triệu người vào năm 2030 (General Statistics Office of Vietnam, 2025), trong khi có tới 4,8% người cao tuổi có ít nhất một dạng suy giảm chức năng vẫn có nhu cầu chăm sóc chưa được đáp ứng đầy đủ trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Người mua là nhóm khách hàng quan trọng nhất vì họ là người trực tiếp cảm nhận vấn đề “muốn chăm sóc nhưng không thể có mặt”, đồng thời có khả năng đưa ra quyết định và chi trả cho dịch vụ. Người sử dụng là người cao tuổi vì đây là nhóm trực tiếp nhận giá trị từ dịch vụ. Tuy nhiên, HOMACARE không tập trung vào những trường hợp cần chăm sóc y tế chuyên sâu mà ưu tiên người

cao tuổi vẫn tương đối độc lập và cần hỗ trợ một phần trong sinh hoạt hằng ngày.

b. Lý do khách hàng lựa chọn HOMACARE

So với việc tự tìm người chăm sóc thông qua người quen hoặc các dịch vụ chăm sóc truyền thống, HOMACARE hướng tới cung cấp một quy trình kết nối - điều phối - theo dõi thống nhất. Khách hàng không chỉ tìm được người hỗ trợ cha mẹ mà còn có thể:

- Biết ai đang chăm sóc.
- Biết khi nào hoạt động chăm sóc được thực hiện.
- Biết sau mỗi lần chăm sóc có chuyện gì xảy ra.
- Có một đầu mối để hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Do đó, HOMACARE cạnh tranh bằng sự tin cậy, tính liên tục và khả năng theo dõi quá trình chăm sóc từ xa thay vì chỉ dựa vào việc cung cấp chuyên viên chăm sóc. Trên thị trường đã có các dịch vụ như bCare thuộc nền tảng bTasker cung cấp người chăm sóc tại nhà với tên gọi “người giúp việc”. Tuy nhiên, HOMACARE không chỉ kết nối người chăm sóc với người cao tuổi mà còn trực tiếp điều phối quá trình chăm sóc và cung cấp thông tin cập nhật cho người thân ở xa. Sau mỗi ca, người chăm sóc ghi nhận kết quả, hình ảnh và tình trạng của cha mẹ trên nền tảng để người con có thể theo dõi, phản hồi và đánh giá dịch vụ từ xa.

bCare (bTasker)	HOMACARE
Cung cấp người chăm sóc tại nhà	Kết nối gia đình - Chuyên viên chăm sóc sức khỏe tại gia - hệ thống điều phối
Đặt lịch và sử dụng dịch vụ	Đặt lịch, theo dõi và quản lý quá trình chăm sóc
Tập trung vào người chăm sóc	Tập trung vào những gia đình có sự xa cách về không gian địa lý giữa những người thân (con cái, họ hàng - cha mẹ)
Gia đình sử dụng dịch vụ	Gia đình tham gia và theo dõi quá trình chăm sóc

Bảng 2: So sánh điểm khác biệt với đối thủ

Điểm khác biệt cốt lõi: bCare giúp gia đình tìm người chăm sóc trong khi HOMACARE giúp gia đình ở xa vẫn tham gia và biết cha mẹ đang được chăm sóc như thế nào.

2.1.4. Giá trị đối với cộng đồng và xã hội

HOMACARE có thể tạo ra giá trị xã hội ở ba khía cạnh chính:

- Đối với người cao tuổi: Hỗ trợ người cao tuổi trong các hoạt động hàng ngày tại nhà, duy trì sự độc lập theo xu hướng xã hội, giải quyết các vấn đề tâm lý.
- Đối với gia đình: Giúp giảm khoảng cách chăm sóc giữa các thế hệ, đặc biệt với những gia đình có con cái học tập, làm việc hoặc sinh sống xa quê.
- Đối với cộng đồng: Tạo thêm một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại địa phương, đồng thời hình thành mạng lưới những người có khả năng tham gia hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi một cách có tổ chức.

Về lâu dài, HOMACARE hướng tới việc góp phần chuyển hoạt động chăm sóc người cao tuổi từ hình thức tự phát, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình sang mô hình có tổ chức, có điều phối và có khả năng theo dõi chất lượng.

Một nghiên cứu của TS. Tomoko Kamei và các cộng sự tại Nhật Bản, một quốc gia có dân số già hóa nhanh chóng, cho thấy kết quả phân tích tổng hợp từ 13 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trên 4.709 người cao tuổi đang mắc các bệnh mãn tính đã chứng minh rằng người già khi được chăm sóc thường xuyên, đã giảm đáng kể nguy cơ nhập viện của người lớn tuổi trong giai đoạn đầu (từ 2 đến 6 tháng) so với nhóm không nhận được sự chăm sóc tích cực (Kamei và cộng sự, 2024).

Ngoài ra, vào năm 2018, tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh vai trò của việc đánh giá sức khỏe toàn diện, thiết lập kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa và duy trì sự điều phối liên tục giữa các chuyên gia y tế nhằm nâng cao chất lượng quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng (World Health Organization, 2018). Vì vậy, HOMACARE tập trung vào điều phối các hoạt động chăm sóc phi y tế như hỗ trợ sinh hoạt, đồng hành, nhắc thuốc, theo dõi và báo cáo và liên kết với các cơ sở y tế, bệnh viện tại địa phương như những đối tác chuyên môn y tế. Việc sử dụng cơ sở thứ ba hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi đã được quy định tại Điều 11 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12, với điều kiện phải có sự đồng ý của người cao tuổi và việc ủy nhiệm được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

2.2. Tính khả thi

2.2.1. Về mặt kỹ thuật

Việc xây dựng sản phẩm là khả thi vì các thành phần công nghệ cốt lõi như ứng dụng đặt lịch, bảng điều khiển, hệ thống thanh toán,... đều là công nghệ phổ biến, không đòi hỏi phải phát triển công nghệ lõi mới từ giai đoạn đầu. Yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất sẽ nằm ở quy trình vận hành phía sau thay vì phần mềm: hệ thống cần đảm bảo xác minh danh tính và kỹ năng của chuyên viên chăm sóc trước khi đưa vào mạng lưới, ghi nhận check-in/check-out theo thời

gian thực, và tuân thủ các yêu cầu về quản lý dữ liệu cá nhân theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 (Quốc hội, 2025), bao gồm xác định mục đích thu thập, giới hạn dữ liệu cần thiết, cơ chế đồng ý và kiểm soát quyền truy cập đối với dữ liệu sức khỏe nhạy cảm của người cao tuổi.

2.2.2. Về cơ cấu chi phí

Mô hình kinh doanh của HOMACARE được xây dựng nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững về mặt tài chính. Khác với các nền tảng kết nối thuần túy chỉ phát sinh chi phí vận hành công nghệ, dịch vụ của HOMACARE đòi hỏi nguồn nhân lực điều phối có kỹ năng giao tiếp và chuyên môn chăm sóc cao. Vì vậy, dòng tiền và ngân sách của HOMACARE được tập trung ưu tiên cho chất lượng dịch vụ, đảm bảo mức giá phản ánh đúng giá trị gia tăng mà đội ngũ điều phối mang lại cho gia đình. Mức định giá này sẽ được thử nghiệm và kiểm chứng qua các giai đoạn thí điểm trước khi áp dụng chính thức trên toàn hệ thống.

2.2.3. Thuận lợi và khó khăn

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai đã được nhóm nghiên cứu nhận diện thông qua phân tích rào cản gia nhập thị trường. Điểm thuận lợi là thị trường đã có bằng chứng khả thi thương mại khi cho thấy dịch vụ bCare by bTasker hiện đang cung cấp chăm sóc người cao tuổi tại nhà với các hình thức linh hoạt, cho phép gia đình đặt và quản lý dịch vụ qua ứng dụng ngay cả khi sống ở xa hoặc ở nước ngoài (bTasker, n.d.). Chính sự tồn tại và vận hành của đối thủ này là minh chứng gián tiếp cho tính khả thi thương mại của mô hình. Khó khăn của HOMACARE chủ yếu nằm ở việc xây dựng và duy trì niềm tin, đảm bảo nguồn cung chuyên viên chăm sóc có chất lượng, đạt đủ mật độ cung - cầu tại một khu vực địa lý và duy trì tính nhất quán trong chất lượng dịch vụ khi chất lượng phụ thuộc phần lớn vào con người thay vì vào hệ thống.

2.2.4. Về thời gian

Dự án cũng được đo lường qua các mốc thời gian và tiêu chí nghiệm thu. Đối với giai đoạn thí điểm 6 - 12 tháng, các mốc thời gian nhóm đang đề xuất bao gồm:

- Hoàn tất thiết lập mạng lưới chuyên viên chăm sóc ban đầu tại khu vực thí điểm
- Triển khai chương trình thí điểm miễn phí với một số lượng gia đình và chuyên viên chăm sóc giới hạn
- Đánh giá kết quả tại cuối kỳ thí điểm để quyết định có mở rộng hay không

Các tiêu chí nghiệm thu tương ứng có thể bao gồm: đạt tỷ lệ kết nối thành công và thời gian tìm chuyên viên phù hợp ở mức chấp nhận được, đạt tỷ lệ sử dụng lại và mức hài lòng của gia đình lẫn người cao tuổi đủ cao, số lượng khiếu nại ở mức thấp,... Quan trọng nhất, nhóm phải xác nhận được mức sẵn sàng chi trả của khách hàng để có đủ thông tin hỗ trợ cho mô hình doanh thu đề xuất. Các tiêu chí này chính là điều kiện để chuyển từ giai đoạn xác thực sang giai đoạn đầu tư mở rộng.

2.3. Tính độc đáo, sáng tạo

Tính độc đáo của HOMACARE nằm ở việc chuyển từ mô hình “kết nối người chăm sóc” sang mô hình “điều phối toàn bộ hành trình chăm sóc từ xa”. Giá trị “điều phối đáng tin cậy” này được xây dựng dựa trên sự an tâm về pháp lý thông qua hợp đồng dịch vụ ủy nhiệm chăm sóc minh bạch, tuân thủ theo Điều 11 trong Luật Người cao tuổi (Quốc hội, 2009) và cơ chế tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Quốc hội, 2025). Đồng thời, nền tảng chuẩn hóa chất lượng đầu vào bằng chương trình đào tạo bài bản hợp tác với các đơn vị uy tín, kết hợp với quy trình khảo sát chuyên sâu nhu cầu của từng gia đình để thiết kế kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa.

Sự khác biệt của HOMACARE nằm ở cách chúng tôi nâng tầm nghề chăm sóc sức khỏe, coi đây là một nghề nghiệp chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên viên của HOMACARE không chỉ sở hữu chuyên môn y tế như vật lý trị liệu hay hỗ trợ vận động, họ còn có kỹ năng giao tiếp và thấu hiểu tâm lý để lắng nghe, trò chuyện và nhắc nhở sinh hoạt. Cùng với nhật ký và báo cáo tình hình hàng ngày qua ứng dụng, HOMACARE đóng vai trò như “một người con thực thụ” thay mặt gia đình ở xa chăm sóc cha mẹ trọn vẹn và an tâm.

Về mặt chi phí và giá cả, đổi mới sáng tạo của HOMACARE không tạo ra lợi thế chi phí thấp nhất thị trường. Mô hình đòi hỏi một sự đầu tư nhất định vào nhân sự khiến chi phí vận hành trên mỗi khách hàng cao hơn một nền tảng kết nối thuần túy. Chính vì vậy, lợi thế cạnh tranh vượt trội không nằm ở việc HOMACARE chào giá thấp nhất mà nằm ở giá trị nhận được trên mỗi đồng chi trả, nghĩa là gia đình trả tiền không chỉ để tìm được chuyên viên chăm sóc mà còn để có được sự minh bạch liên tục qua Bảng quản lý chăm sóc gia đình và một đầu mối điều phối duy nhất, đúng như cách tiếp cận chăm sóc tích hợp mà WHO khuyến nghị cho người cao tuổi cần nhiều loại hỗ trợ khác nhau thay vì các dịch vụ rời rạc (World Health Organization, 2018).

Đây là dạng đổi mới sáng tạo trong mô hình vận hành và trải nghiệm dịch vụ hơn là đổi mới sáng tạo về công nghệ lõi hay về cấu trúc chi phí bởi đối thủ

của HOMACARE sẽ khó có thể sao chép nhanh vì đòi hỏi phải tích lũy dữ liệu và uy tín theo thời gian.

2.4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

2.4.1. Khát vọng của HOMACARE

Hành trình của HOMACARE bắt nguồn từ một trăn trở giản đơn nhưng đau đáu của hàng triệu người con đất Việt đang lập nghiệp xa nhà: *“Làm sao để vẹn tròn đạo hiếu khi cha mẹ già vẫn ở lại quê hương?”*. Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử với tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, khi tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên 9,3% và chỉ số già hóa đạt 60,2% vào năm 2024 (Tổng cục Thống kê et al., 2021; Tổng cục Thống kê, 2024). Số lượng người cao tuổi đã chạm mốc 14,2 triệu người vào năm 2024 và dự kiến sẽ nhanh chóng xấp xỉ đạt 18 triệu người vào năm 2030 (Tổng cục Thống kê, 2024). Thực tế đáng buồn là có đến gần hai phần ba số người cao tuổi tự đánh giá sức khỏe của mình ở mức yếu hoặc rất yếu. Khi tuổi tác ập đến mang theo những gánh nặng bệnh tật mãn tính và sự suy giảm vận động, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ bỗng trở nên vô cùng khó khăn.

Trong bối cảnh đó, khát vọng dài hạn HOMACARE mong muốn mang tới trong định hướng mười năm là trở thành những người đi tiên phong, khai phá và dẫn dắt, định nghĩa cụm từ *“Kinh tế Bạc”* tại Việt Nam. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ toàn bộ hệ sinh thái kinh tế, sản phẩm và dịch vụ được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ cho thể hệ người cao tuổi. Chúng tôi hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giải pháp thích nghi với xu hướng già hoá của xã hội, thay vì buộc cha mẹ phải rời bỏ làng quê quen thuộc để dọn vào các viện dưỡng lão xa lạ - nơi vốn chịu định kiến văn hóa nặng nề tại Việt Nam, hay ép buộc các ông, các bà phải bon chen với cuộc sống thành thị với không gian chật hẹp, đầy áp lực của con cái, người cao tuổi sẽ được an lòng dưỡng già, sống vui khỏe và độc lập ngay trong chính ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm và cộng đồng láng giềng gần bó lâu năm của mình.

Trong khoảng 3-5 năm, HOMACARE hướng tới trở thành nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực điều phối chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam, tập trung vào những gia đình có người thân sống ở xa và không thể trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc. Để đạt được mục tiêu này, HOMACARE cần từng bước xây dựng năng lực về mạng lưới người chăm sóc, điều phối chăm sóc, quản lý thông tin, kiểm soát chất lượng và phát triển hệ thống đối tác.

2.4.2. Kế hoạch vận hành nền tảng HOMACARE

Để bảo đảm dịch vụ được triển khai thống nhất, kiểm soát chất lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, HOMACARE xây dựng kế hoạch sản xuất dịch

vụ theo bốn giai đoạn: “*Thấu hiểu*”, “*Khởi tạo*”, “*Vận hành*” và “*Đánh giá kết quả*”. Mỗi giai đoạn có mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể, tạo cơ sở cho việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo và từng bước hoàn thiện mô hình.

a. Giai đoạn 1: Thấu hiểu

HOMACARE tiến hành tiếp cận và đánh giá nhu cầu của 100 hộ gia đình người cao tuổi đầu tiên tại khu vực thử nghiệm. Thông qua các buổi gặp gỡ trực tiếp, dự án thu thập thông tin về khả năng sinh hoạt hằng ngày, thói quen, nhu cầu hỗ trợ và đặc điểm của từng người cao tuổi để xây dựng hồ sơ chăm sóc phù hợp. Hoạt động tiếp xúc trực tiếp đồng thời giúp người cao tuổi làm quen với người cung cấp dịch vụ, tạo nền tảng cho sự tin tưởng và hợp tác trong quá trình chăm sóc.

Kết quả đầu ra: Hồ sơ nhu cầu của nhóm khách hàng thử nghiệm và cơ sở dữ liệu phục vụ thiết kế dịch vụ.

b. Giai đoạn 2: Khởi tạo

Trên cơ sở nhu cầu đã xác định, HOMACARE triển khai tuyển chọn và đào tạo Chuyên viên chăm sóc tại các khu vực hoạt động. Tiêu chuẩn tuyển chọn tập trung vào thông tin cá nhân, kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc, giao tiếp và mức độ phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi. Người được tuyển chọn phải trải qua quá trình xác minh, đào tạo và đánh giá trước khi tham gia cung cấp dịch vụ. Dự kiến, 50 Chuyên viên chăm sóc đầu tiên sẽ hoàn thành đào tạo và đạt yêu cầu đánh giá để tham gia vận hành.

Song song với quá trình đào tạo, HOMACARE xây dựng quy trình phân công, điều phối và phương án bố trí người thay thế nhằm hạn chế gián đoạn dịch vụ khi phát sinh trường hợp bất khả kháng.

Kết quả đầu ra: Đội ngũ chuyên viên chăm sóc có đủ chứng chỉ hành nghề, quy trình cung cấp dịch vụ và cơ chế vận hành nền tảng và theo dõi chuyên viên được thiết lập.

c. Giai đoạn 3: Vận hành

HOMACARE chính thức cung cấp dịch vụ chăm sóc định kỳ theo các gói đăng ký của gia đình. Chuyên viên chăm sóc đến nhà theo lịch đã thống nhất và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng người cao tuổi. Sau mỗi lần cung cấp dịch vụ, các thông tin về thời gian thực hiện, nội dung hỗ trợ, tình trạng đáng chú ý và phản hồi của gia đình được ghi nhận trên hệ thống.

Người thân ở xa có thể theo dõi những thông tin cần thiết về tình hình sinh hoạt của cha mẹ thông qua hệ thống cập nhật của HOMACARE. Điều phối viên chịu trách nhiệm theo dõi quá trình cung cấp dịch vụ, hỗ trợ Chuyên viên chăm sóc và xử lý các tình huống phát sinh. Những trường hợp vượt quá phạm

vi hỗ trợ của Chuyên viên chăm sóc sẽ được chuyển đến gia đình hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp.

Trong quá trình vận hành, HOMACARE theo dõi các chỉ số như tỷ lệ hoàn thành dịch vụ, tỷ lệ hủy, thời gian đáp ứng, tỷ lệ thay đổi Chuyên viên chăm sóc, số lượng sự cố và mức độ hài lòng của gia đình nhằm duy trì chất lượng khi quy mô dịch vụ tăng lên.

Kết quả đầu ra: Dịch vụ được cung cấp ổn định, dữ liệu vận hành được tích lũy và hệ thống kiểm soát chất lượng được hình thành.

d. Giai đoạn 4: Đánh giá, cải tiến và hoàn thiện mô hình

Sau một chu kỳ vận hành, HOMACARE tiến hành đánh giá trên ba phương diện: hiệu quả cung cấp dịch vụ, trải nghiệm của gia đình và khả năng vận hành của hệ thống. Các tiêu chí trọng tâm bao gồm mức độ hoàn thành kế hoạch chăm sóc, mức độ hài lòng, khả năng duy trì sử dụng dịch vụ, tỷ lệ sự cố, khả năng đáp ứng nhu cầu và mức độ tiếp cận thông tin của người thân ở xa.

Kết quả đánh giá được sử dụng để điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển chọn, nội dung đào tạo, phương thức phân công, quy trình điều phối và các chức năng của hệ thống. Các tác động dài hạn đến sức khỏe và tâm lý của người cao tuổi được tiếp tục theo dõi và kiểm chứng, thay vì được mặc định là kết quả trực tiếp của dịch vụ.

Kết quả đầu ra: Bộ quy trình cung cấp dịch vụ được hoàn thiện, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng được chuẩn hóa và mô hình HOMACARE được hoàn thiện làm cơ sở mở rộng sang các khu vực tiếp theo.

2.4.3. Đơn vị tham gia, đối tác chiến lược

Mô hình HOMACARE được xây dựng trên cơ sở kết nối giữa nền tảng điều phối trung tâm và các nguồn lực chăm sóc tại địa phương. HOMACARE tập trung kiểm soát các hoạt động cốt lõi như đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch chăm sóc, lựa chọn và điều phối chuyên viên chăm sóc, quản lý thông tin và kiểm soát chất lượng; các nguồn lực về nhân sự, chuyên môn, cộng đồng và tài chính được huy động thông qua hệ thống đối tác.

Nhóm đối tác	Đối tượng hợp tác	Vai trò đối với HOMACARE
Đối tác nhân lực và giáo dục	Cơ sở đào tạo điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; chuyên gia chăm sóc; nguồn nhân lực địa phương phù hợp	Tuyển chọn, đào tạo, đánh giá và bổ sung nguồn Chuyên viên chăm sóc; xây dựng

		tiêu chuẩn năng lực và quy trình đào tạo
Đối tác chuyên môn và bảo hiểm	Cơ sở y tế, phục hồi chức năng, đơn vị chuyên môn; doanh nghiệp bảo hiểm	Hỗ trợ các nhu cầu vượt phạm vi chăm sóc thông thường; kết nối dịch vụ chuyên môn và bổ sung giải pháp bảo vệ phù hợp cho người cao tuổi, Chuyên viên chăm sóc
Đối tác cộng đồng và địa phương	Hội Người cao tuổi, câu lạc bộ, khu dân cư, trạm y tế và các tổ chức xã hội địa phương	Tiếp cận người cao tuổi, xây dựng niềm tin, giới thiệu nhu cầu và hình thành mạng lưới chăm sóc tại từng khu vực
Đối tác tài chính và phát triển	Quỹ đầu tư, vườn ươm, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và tổ chức quan tâm đến đổi mới sáng tạo, tác động xã hội	Huy động nguồn lực tài chính và chuyên môn để phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và mở rộng hoạt động

Bảng 3: Các nhóm đối tác chiến lược

2.4.4. Kênh phân phối

Kênh phân phối	Cách thức triển khai	Mục tiêu
Kênh trực tuyến	Website, mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến và nội dung về chăm sóc người cao tuổi; tập trung vào các tình huống thực tế để phát sinh nhu cầu	Tiếp cận con cái sống xa gia đình, xây dựng nhận diện và tạo niềm tin trước khi sử dụng dịch vụ
Kênh cộng đồng và địa phương	Hội Người cao tuổi, trạm y tế, câu lạc bộ, khu dân cư và các tổ chức	Tiếp cận trực tiếp người cao tuổi và gia

	xã hội tại khu vực cung cấp dịch vụ	đình, giảm rào cản tâm lý và tăng mức độ tin cậy đối với dịch vụ
Kênh giới thiệu từ khách hàng	Khuyến khích khách hàng đã sử dụng dịch vụ giới thiệu HOMACARE cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp	Tạo nguồn khách hàng mới từ mạng lưới sẵn có, đồng thời giảm chi phí tiếp cận khách hàng khi chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định

Bảng 4: Các kênh phân phối

2.4.5. Phân tích và quản trị rủi ro vận hành chủ yếu

Nhóm rủi ro	Rủi ro cụ thể	Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Giải pháp ứng phó
Rủi ro thị trường	- Nhu cầu thực tế thấp hơn dự kiến hoặc khách hàng chưa sẵn sàng sử dụng dịch vụ. - Khách hàng nhạy cảm về giá, làm giảm khả năng duy trì sử dụng. - Khó tạo được lượng khách hàng đủ lớn tại một khu vực trong giai đoạn đầu.	Trung bình	Cao	Thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi mở rộng; xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu; kiểm chứng khả năng chi trả thông qua dịch vụ có thu phí; điều chỉnh dịch vụ và mức giá theo phản hồi thực tế.
Rủi ro nhân sự	- Khó tuyển đủ người chăm sóc đáp ứng yêu cầu. - Chất lượng và thái độ của người chăm sóc không đồng đều. - Người chăm sóc nghỉ hoặc thay đổi lịch đột xuất, gây gián đoạn dịch vụ.	Cao	Cao	Xây dựng nguồn tuyển từ nhiều kênh; chuẩn hóa tuyển chọn, xác minh và đào tạo; duy trì danh sách người chăm sóc dự phòng; đánh giá định kỳ và có cơ chế thay thế.

Rủi ro vận hành và chất lượng	- Sai sót trong quá trình điều phối giữa gia đình, người chăm sóc và HOMACARE. - Dịch vụ không được thực hiện đúng lịch hoặc đúng kế hoạch. - Chất lượng không ổn định khi số lượng gia đình tăng.	Cao	Cao	Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ; phân định rõ trách nhiệm; theo dõi quá trình thực hiện; thu thập phản hồi sau dịch vụ; sử dụng dữ liệu để kiểm soát và cải thiện chất lượng.
Rủi ro an toàn, pháp lý và dữ liệu	- Người cao tuổi gặp tai nạn hoặc tình huống bất thường trong quá trình sử dụng dịch vụ. - Người chăm sóc thực hiện công việc vượt quá phạm vi cho phép. - Thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan đến người cao tuổi bị sử dụng hoặc truy cập không phù hợp.	Trung bình	Rất cao	Xác định rõ phạm vi chăm sóc phi y tế; xây dựng quy trình xử lý và chuyển cấp sự cố; đào tạo về an toàn; chuẩn hóa hợp đồng; phân quyền truy cập và kiểm soát việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu.
Rủi ro tài chính và mở rộng	- Chi phí tuyển dụng, đào tạo và điều phối cao hơn dự kiến. - Doanh thu ban đầu chưa đủ bù đắp chi phí vận hành. - Mở rộng quá nhanh làm tăng chi phí và suy giảm chất lượng dịch vụ.	Cao	Cao	Triển khai theo từng khu vực; kiểm soát chi phí theo từng giai đoạn; theo dõi hiệu quả trên mỗi khách hàng; chỉ tăng quy mô khi nhu cầu, nguồn cung, chất lượng và hiệu quả vận hành đã được kiểm chứng.

Bảng 5: Quản trị Rủi ro chủ yếu

2.5. Kết quả tiềm năng của dự án

2.5.1. Các nguồn thu chính, định giá và dự kiến doanh thu

HOMACARE đã tham chiếu mô hình hỗ trợ sinh hoạt theo giờ của các ứng dụng cung cấp dịch vụ giúp việc tại nhà theo giờ tại Việt Nam của một số ứng dụng, điển hình là bTaskee (mức giá dao động từ 100.000 VNĐ đến 150.000 VNĐ/giờ) và mô hình tìm người chăm sóc, “bạn đồng hành của người

lớn tuổi” mang tên Papa Pals tại Mỹ để thiết lập chính sách giá phù hợp với bối cảnh thị trường Việt Nam. Toàn bộ mức định giá được tinh chỉnh dựa trên thu nhập bình quân đầu người, chỉ số giá tiêu dùng và khả năng chi trả thực tế của nhóm khách hàng mục tiêu là *những người con trong độ tuổi 35 - 50 có công việc ổn định (trên 30 triệu VNĐ/tháng/người) tại các trung tâm kinh tế lớn*. Hệ sinh thái dịch vụ được cơ cấu lại thành ba gói định kỳ và một hình thức hỗ trợ đặc biệt nhằm tối ưu hóa sự lựa chọn cho gia đình và tạo dòng tiền ổn định cho nền tảng.

Tên dịch vụ	Thời lượng	Nội dung	Mức giá (VNĐ)
Ân cần	4 giờ (18:00 – 22:00)	Trò chuyện, hỗ trợ dùng bữa, nhắc thuốc, đi bộ/vận động nhẹ, hỗ trợ sinh hoạt cá nhân cơ bản, kiểm tra an toàn trước khi kết thúc ca, báo cáo cho gia đình	320.000/buổi
Chăm chút	8 - 12 giờ (9:00 - 21:00)	Chuẩn bị và hỗ trợ ăn uống; nhắc thuốc; hỗ trợ vệ sinh cá nhân cơ bản; vận động nhẹ; hỗ trợ các sinh hoạt theo ngày, trò chuyện/đồng hành; theo dõi tình trạng trong ngày; cập nhật báo cáo cho gia đình và nhật ký sinh hoạt	600.000 - 800.000/buổi
Dưỡng sinh	60 phút (Theo ca)	Chuyên viên chăm sóc thực hiện tập vận động phục hồi chức năng, tập cơ/khớp theo phác đồ y tế cho người cao tuổi.	350.000/buổi
Gói Thân tình	7 ngày/tháng (8 giờ/ngày)	- Khách hàng được lựa chọn 7 ngày trong tháng khi book - Chuẩn bị và hỗ trợ ăn uống; nhắc thuốc; hỗ trợ vệ sinh cá nhân cơ bản; vận động nhẹ; hỗ trợ các sinh hoạt theo ngày, trò chuyện/đồng hành; theo dõi tình trạng trong	2.800.000/tháng

		ngày; cập nhật báo cáo cho gia đình và nhật ký sinh hoạt	
--	--	--	--

Bảng 6: Bảng giá dịch vụ chăm sóc tận tâm theo nhu cầu

Về cơ chế dòng tiền, HOMACARE vận hành theo mô hình nền tảng công nghệ kết nối, yêu cầu khách hàng thanh toán trả trước toàn bộ phí dịch vụ theo tháng thông qua ứng dụng. Nền tảng thiết lập *tỷ lệ chiết khấu ở mức 22% trên tổng giá trị hợp đồng* nhằm duy trì hoạt động quản lý, vận hành hệ thống máy chủ, kiểm soát chất lượng và chi phí tiếp thị. Phần doanh thu 78% còn lại được giải ngân trực tiếp cho những chuyên viên chăm sóc tại địa phương nhằm đảm bảo mức thu nhập cạnh tranh, tạo động lực giữ chân người lao động và duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn hệ thống.

Để phục vụ dự báo tài chính, cơ cấu doanh thu từ nhóm khách hàng sử dụng gói định kỳ được giả định phân bổ theo tỷ trọng thực tế nhu cầu thị trường: *60% khách hàng lựa chọn Gói Thân tình (nhu cầu hỗ trợ 7 ngày/tháng với chi phí tối ưu), 30% lựa chọn các gói chăm sóc phối hợp nâng cao, và 10% lựa chọn gói phục hồi chuyên sâu/dưỡng sinh.*

Chỉ tiêu tài chính dự phòng	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Khách hàng sử dụng gói định kỳ (lượt TB/tháng)	40	100	300
Số lượt dịch vụ linh hoạt trong năm (lượt)	400	1.200	3.500
Giá trị giao dịch trung bình/khách/tháng	2.800.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ	3.200.000 VNĐ

Chỉ tiêu tài chính dự phòng	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Tổng GMV trên nền tảng	1.424.000.00 VNĐ	3.960.000.000 VNĐ	12.660.000.000 VNĐ
Doanh thu thuần của nền tảng (22%)	313.280.000 VNĐ	871.200.000 VNĐ	2.785.200.000 VNĐ

Bảng 8: Dự báo tài chính của nền tảng trong 3 năm

2.5.2. Chi phí vận hành

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi quyết định uy tín thương hiệu và khả năng giữ chân khách hàng đối với một nền tảng chăm sóc sức khỏe qua nền tảng công nghệ. Nhằm chuẩn hóa năng lực cho đội ngũ nhân sự là chuyên viên chăm sóc sức khỏe, HOMACARE thiết lập ngân sách hợp tác chiến lược với các cơ sở đào tạo y khoa uy tín như *Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học Y Hà Nội và các trường cao đẳng y tế địa phương* để xây dựng chương trình giảng dạy thực hành chăm sóc người cao tuổi chuẩn hóa, đồng thời tuyển dụng và đào tạo bổ sung các lao động phổ thông từ các trung tâm môi giới việc làm. Chi phí đào tạo được phân bổ thành hai hợp phần: chi phí bản quyền/xây dựng chương trình khung ban đầu và chi phí đào tạo trực tiếp trên mỗi nhân sự (đã bao gồm tài liệu, dụng cụ thực hành và kiểm tra chứng chỉ đầu ra). Mức chi phí đào tạo bình quân dự kiến từ 800.000 đến 1.200.000 VNĐ/người cho khóa huấn luyện căn bản 30 giờ về kỹ năng giao tiếp cảm xúc, kỹ thuật chuyển dịch vận động an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp. Việc đầu tư bài bản vào khâu đào tạo không chỉ giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro vận hành tại gia đình khách hàng mà còn tạo nền tảng để nhân sự gắn bó lâu dài với hệ sinh thái.

Chi phí tiếp thị (CAC) được tính toán dựa trên đặc thù hành vi mua sắm dịch vụ y tế - xã hội của nhóm khách hàng mục tiêu là con cái trong độ tuổi 35 - 45 sinh sống xa nhà. Cụ thể, dự án phân bổ *60% ngân sách tiếp thị vào hình thức tiếp thị nội dung qua câu chuyện*, chọn niềm tin, cảm xúc làm mục tiêu trên các nền tảng số như Meta, Google, Youtube và TikTok. *40% ngân sách còn lại*

được dành cho hoạt động tiếp thị liên kết thông qua cộng đồng y tế, loa phường, các hội nhóm kiều bào và chương trình giới thiệu nhận ưu đãi từ khách hàng hiện hữu. Chi phí tiếp thị dự kiến của HOMACARE nằm trong khoảng 350.000 – 500.000 VNĐ/khách hàng mới. Với giá trị vòng đời khách hàng cao nhờ mô hình gói đăng ký định kỳ theo tháng, tỷ lệ LTV/CAC (giá trị vòng đời khách hàng/chi phí tiếp thị) dự phóng đạt trên 4,5 lần, khẳng định tính hiệu quả cao của ngân sách tiếp thị.

Cơ cấu chi phí lương và nhân sự của HOMACARE được tối ưu hóa theo mô hình vận hành tinh gọn nhằm duy trì sự linh hoạt về mặt tài chính. Bộ máy nhân sự cốt lõi của dự án chia làm hai nhóm chính: đội ngũ công nghệ - vận hành trung tâm và đội ngũ quản lý chăm sóc khu vực. Quản lý sẽ đóng vai trò là cầu nối giám sát chất lượng tại từng cụm địa bàn, thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá đột xuất ca làm việc của người chăm sóc và hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh. *Mức lương cứng cho mỗi quản lý địa phương dao động từ 10.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng* cộng với phụ cấp hiệu suất dựa trên tỷ lệ duy trì khách hàng trong cụm quản lý. Trong khi đó, thù lao cho nhân sự trực tiếp chăm sóc khách hàng được hạch toán trực tiếp vào chi phí biến đổi, chiếm 78% tổng giá trị giao dịch phát sinh. Việc tách bạch rõ ràng giữa định phí lương bộ máy vận hành và biến phí thù lao người lao động giúp HOMACARE kiểm soát tốt rủi ro tài chính trong giai đoạn đầu khởi chạy và dễ dàng mở rộng quy mô khi dòng tiền tăng trưởng.

2.5.3. Kết quả dự tính

Để đảm bảo tính cân trọng trong phân tích tài chính, các chỉ tiêu định lượng được tính toán dựa trên *tổng vốn đầu tư dự án (I_0) là 850.000.000 VNĐ*, bao gồm toàn bộ chi phí phát triển công nghệ, pháp lý, và nguồn tài trợ hạ tầng ban đầu. Dòng tiền thuần (CF) được xác định bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi chi phí vận hành thường xuyên (OPEX) bao gồm chi phí máy chủ, lương đội ngũ điều phối, marketing và hành chính. *Trong năm đầu phát hành nền tảng, dòng tiền thuần thu về đạt 240.000.000 VNĐ; tăng trưởng lên 700.000.000 VNĐ vào năm thứ hai sau đó bứt phá lên thành 1.500.000.000 VNĐ trong Năm 3.*

Áp dụng phương pháp cộng dồn dòng tiền thuần, dự án thu hồi được 240.000.000 VNĐ trong năm đầu tiên, để lại khoản vốn chưa thu hồi là 610.000.000 VNĐ. Bước sang năm thứ hai, với dòng tiền thuần 700.000.000 VNĐ vượt mức vốn còn khuyết, thời gian hoàn vốn (T) được xác định chính xác ở mức 1,87 năm (*tương đương 22,5 tháng sau khi đưa nền tảng vào hoạt động chính thức*). Đây là tốc độ thu hồi vốn khả quan, phản ánh đúng đặc thù của một

mô hình dịch vụ công nghệ tinh gọn, không đọng vốn vào cơ sở vật chất hay hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, hiệu quả sinh lời của dự án được củng cố vững chắc thông qua chỉ số Giá trị hiện tại ròng (NPV). Với *tỷ lệ chiết khấu* $r = 10\%$ đại diện cho chi phí cơ hội của vốn an toàn, *NPV tính toán qua 3 năm đạt mức 1.073.666.416 VNĐ*. Chỉ số dương vượt mốc 1 tỷ đồng này là minh chứng rõ nét cho thấy cấu trúc chi phí - doanh thu của HOMACARE được tối ưu hóa tốt, dự án không chỉ có khả năng tự chủ tài chính mà còn tạo ra giá trị thặng dư hấp dẫn cho các bên tham gia đầu tư.

2.5.4. Tăng trưởng xã hội

Sở hữu mô hình nền tảng công nghệ tinh gọn, HOMACARE nắm giữ lợi thế mở rộng quy mô vượt trội sang các vùng địa lý khác trong nước với mục tiêu trung và dài hạn mà không chịu áp lực chi phí mặt bằng cố định. Khi chuỗi quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng được đóng gói hoàn thiện, hệ thống có thể linh hoạt nhúng thêm các chuỗi giá trị dịch vụ y tế liên kết như tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa, kết nối hội chẩn bác sĩ từ xa, và phân phối thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh IoT nhằm tối đa hóa doanh thu trên mỗi khách hàng.

Song song với tiềm năng thương mại, cốt lõi dự án kiến tạo những tác động xã hội sâu sắc bằng việc giải quyết trực tiếp nhu cầu duy trì nhịp sống thường nhật cho người cao tuổi ngay tại không gian sống thân thuộc, nói cách khác là hiện thực hoá mục tiêu của nền kinh tế Bạc. Cơ chế cập nhật nhật ký minh bạch trên ứng dụng đóng vai trò như một giải pháp trị liệu tâm lý, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và xoa dịu nỗi bất an cho những người con đang làm việc xa quê. Hơn thế nữa, nền tảng còn đóng vai trò bộ phận an sinh, chuyển hóa thời gian nhàn rỗi của lao động tự do tại địa phương thành nguồn thu nhập ổn định, đồng thời chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn cho nhóm ngành chăm sóc đang rất khát nhân lực này.

2.6. Nguồn lực thực hiện

2.6.1. Nguồn nhân lực thực hiện dự án

Đội ngũ HOMACARE gồm các thành viên hiện đang là sinh viên năm Ba Đại học Kinh tế Quốc dân có nền tảng chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tế trong quản lý và triển khai dự án, đồng thời có tinh thần trách nhiệm và mức độ cam kết cao đối với mục tiêu chung của dự án.

Thành viên	Chuyên môn và kinh nghiệm nổi bật	Vai trò tại HOMACARE
------------	-----------------------------------	----------------------

Nguyễn Tiến Anh	- Ngành học: Quản trị Kinh doanh. GPA: 3.88/4.0. - Kinh nghiệm thực tế: Trưởng Ban Truyền thông - Liên chi Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, trực tiếp quản lý 04 fanpage truyền thông của Khoa với hơn 26.000 người theo dõi; trực tiếp lãnh đạo hơn 150 cộng tác viên ban truyền thông, phân công công việc, giao nhiệm vụ truyền thông và theo dõi tiến độ. - Trưởng Ban Tổ chức Chiến dịch thiện nguyện “Kết Nắng Gom Tình” (11/2025) diễn ra tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, trực tiếp điều phối hơn 200 tình nguyện viên, chiến dịch đạt kết quả: huy động hơn 35 triệu đồng và 1.000 hiện vật, đồng thời trực tiếp tổ chức thiện nguyện tại Phú Thọ.	Tổng điều hành dự án: phụ trách toàn bộ hoạt động vận hành HOMACARE, phân công nhân sự, kiểm soát tiến độ và phối hợp giữa các bộ phận; trực tiếp xây dựng và duy trì quy trình cung cấp dịch vụ.
Nguyễn Minh Hiếu	- Ngành học: Quản trị Kinh doanh. GPA: 3.76/4.0. - Kinh nghiệm thực tế: Là Quản lý sự kiện TEDx NEU 2026 từ tháng 01/2026 đến nay, phụ trách lập kế hoạch tổng thể, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ, xử lý rủi ro và giám sát triển khai hậu cần cho triển lãm tiền sự kiện cũng như hội thảo chính. - Đã tổ chức và thực thi hơn 100 sự kiện cho Khoa, điều phối quản lý ngân sách, dự trù kinh phí và tối ưu hệ thống quản lý hiệu suất đội ngũ. - Từng là Trưởng nhóm dự án Social Pioneers 2026 từ tháng 05/2026 đến tháng 08/2026, cuộc thi toàn quốc về Marketing xã hội; trực tiếp dẫn dắt	Phụ trách phát triển sản phẩm: nghiên cứu nhu cầu người sử dụng, phân tích khách hàng mục tiêu, thiết kế và hoàn thiện các gói dịch vụ chăm sóc của HOMACARE; thử nghiệm và điều chỉnh dịch vụ dựa trên phản hồi thực tế.

	nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng mục tiêu, định hướng thiết kế nhận diện và thuyết trình trước Ban giám khảo; dự án đạt Top 40 toàn quốc.	
Phạm Hiền Minh	- Ngành học: Quản trị Kinh doanh. GPA: 3.87/4.0. - Kinh nghiệm thực tế: Từng là Trưởng dự án kinh doanh Thoang Candle, quản lý nhóm 10 thành viên và trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình từ phát triển sản phẩm, định hướng thương hiệu, marketing đến lập kế hoạch bán hàng. - Dự án đạt khoảng 6 triệu đồng doanh thu/tuần và 3,5 triệu đồng lợi nhuận/tuần, cho thấy kinh nghiệm trực tiếp trong tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh. - Từng giữ vai trò Trưởng nhóm/Phó nhóm trong hơn 100 chương trình cấp Khoa và phối hợp với đối tác, nhà tài trợ, khách mời để triển khai chương trình.	Phụ trách Kinh doanh: xây dựng chính sách giá, phát triển khách hàng, tổ chức bán dịch vụ và theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận; trực tiếp kiểm tra khả năng thương mại hóa của mô hình HOMACARE.
Đỗ Thủy Ngọc	- Ngành học: Quản trị Chất lượng và Đổi mới. GPA: 3.95/4.0. - Kinh nghiệm thực tế: Có hơn 1 năm kinh nghiệm truyền thông; hiện phụ trách nội dung cho 3 kênh, trong đó có kênh hơn 21.000 người theo dõi, đồng thời xây dựng và tối ưu tuyển nội dung theo từng nhóm đối tượng. - Trong chuỗi chương trình định hướng tân sinh viên, hoạt động phụ	Phụ trách Marketing và Truyền thông: xây dựng hình ảnh thương hiệu, lập kế hoạch truyền thông, quản lý các kênh tiếp cận khách hàng và triển khai nội dung nhằm thu hút nhóm khách hàng mục

	trách ghi nhận lượt truy cập tăng 49% và lượt người xem tăng 22%.	tiêu của HOMACARE.
Trần Thị Minh Anh	- Ngành học: Quản trị Kinh doanh. GPA: 3.83/4.0 - Kinh nghiệm thực tế: Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thuyết trình - MC, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi MC Spotlight, Phụ trách chính sản xuất Series Bản tin “Gặp NEU Cuối tuần” và “DAA NEWS” với trên 1.000.000 lượt xem, 15.000 lượt tương tác. Đồng thời có kinh nghiệm tổ chức và điều phối hoạt động, đồng thời trực tiếp liên hệ và phối hợp với doanh nghiệp, đối tác trong quá trình triển khai chương trình. Có kinh nghiệm xây dựng nội dung và tiếp cận khách hàng. - Từng đạt Top 40 dự án tại Cuộc thi Khởi nghiệp FIRE IN HEART TLU, qua đó có kinh nghiệm tham gia xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp.	Phụ trách đối ngoại và đối tác: tìm kiếm, tiếp cận và duy trì quan hệ với các đối tác của HOMACARE; phụ trách trao đổi, phối hợp và xây dựng đề xuất hợp tác với cơ sở đào tạo, đơn vị chuyên môn và các tổ chức cộng đồng. Đồng thời đại diện dự án trong các hoạt động kết nối, làm việc với đối tác và mở rộng mạng lưới hỗ trợ triển khai.

Bảng 9: Nguồn nhân lực thực hiện dự án

2.6.2. Giải pháp huy động vốn triển khai dự án

Trong giai đoạn đầu, HOMACARE sử dụng nguồn vốn tự có của các thành viên trong nhóm và huy động thêm từ gia đình, người thân, bạn bè khi cần thiết để đáp ứng các chi phí thiết yếu như phát triển nền tảng, tuyển chọn và đào tạo người chăm sóc, thử nghiệm dịch vụ và truyền thông tiếp cận khách hàng. Khi mô hình được kiểm chứng về nhu cầu thị trường và khả năng tạo doanh thu, dự án sẽ từng bước huy động thêm vốn từ các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm, quỹ đầu tư và các tổ chức quan tâm đến đổi mới sáng tạo và tác động xã hội. Việc huy động vốn được thực hiện theo từng giai đoạn, gắn với nhu cầu thực tế và kết quả đạt được của dự án nhằm hạn chế đầu tư dàn trải và bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

2.7. Các kênh truyền thông

2.7.1. Cách tiếp cận

Các kênh truyền thông được nhóm nghiên cứu xây dựng theo logic: *thấu hiểu hành trình khách hàng → xác định thông điệp phù hợp cho từng giai đoạn → triển khai kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC)*. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù của HOMACARE, một dịch vụ có rào cản niềm tin cao (khách hàng phải giao cha mẹ mình cho một người lạ), nên việc lựa chọn kênh và thông điệp cần bám sát trạng thái tâm lý thực tế của khách hàng tại từng thời điểm, thay vì tối đa hóa độ phủ.

Đối tượng trung tâm của hành trình là người mua (con cái 35-45 tuổi, sống xa cha mẹ) vì đây là người ra quyết định, chi trả và là những đối tượng trung tâm để nền tảng thuyết phục trả tiền cho dịch vụ. Những người cha, người mẹ lớn tuổi xuất hiện như một nhân vật đồng hành trong hành trình, đặc biệt quan trọng ở giai đoạn những giai đoạn thử nghiệm của dự án, nơi sự chấp nhận của họ quyết định việc dịch vụ có được duy trì hay không.

2.7.2. Kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC)

Giai đoạn IMC	Thời gian	Giai đoạn vận hành tương ứng	Mục tiêu truyền thông	Hoạt động chính	Kênh Truyền thông & chiến thuật hỗ trợ	KPI theo dõi
1. Nhận biết	Tháng 1-2	GD1: Thấu hiểu	Gieo vấn đề “già hóa dân số - con cái sống xa” và bắt đầu xây dựng nhận diện tên sản phẩm HOMACARE tại	- Bài viết/infographic giáo dục thị trường (dấu hiệu cha mẹ cần hỗ trợ, số liệu già hóa dân số) - PR hợp tác báo/trang tin về chủ đề chăm sóc người cao tuổi - Seeding trong nhóm cộng đồng liên quan (hội	Fanpage/TikTok (organic + seeding), PR báo chí, đối tác cộng đồng địa phương	- Reach/impress nội dung - Số lượt theo dõi trang - Số buổi gặp gỡ với đối tác cộng đồng thiết lập được

			khu vực thí điểm phụ huynh chung cư, hội đồng hương) - Bắt đầu liên hệ với Hội Người cao tuổi và trạm y tế phường tại khu vực thí điểm		
2. Cân nhắc	Tháng 2-3	Cuối GD1 - đầu GD2: Khởi tạo	Đưa HOMAC ARE vào nhóm giải pháp được cân nhắc, xây dựng niềm tin ban đầu, tách bạch với hình ảnh “giúp việc theo giờ”	- Case study/hậu trường về quy trình xác minh, đào tạo Chuyên viên - Video/livestream giới thiệu vai trò của chuyên viên chăm sóc - Referral nhẹ từ mạng lưới cá nhân đội sáng lập và 100 hộ gia đình đã khảo sát nhu cầu - Mở landing page đăng ký tư vấn miễn phí	Website/landing page, Zalo OA (tư vấn 1-1), tiếp tục quan hệ cộng đồng địa phương - Số lượt để lại thông tin tư vấn - Tỷ lệ chuyển đổi từ nội dung sang đăng ký tư vấn
3. Chuyển đổi	Tháng 3-4	GD2 - đầu GD3: Khởi tạo → Vận hành	Chuyển các gia đình đang cân nhắc thành khách hàng	- Ưu đãi dùng thử buổi đầu hoặc gói An Tâm cho nhóm hộ gia đình đầu tiên tại khu vực thí điểm - Tổ chức buổi gặp gỡ làm quen	Điều phối viên tư vấn trực tiếp qua Zalo/điện thoại; điểm - Số hộ gia đình chuyển đổi thành khách hàng trả phí

		(khi 50 Chuyên viên đầu tiên hoàn thành đào tạo, đủ điều kiện chăm sóc)	dùng thử/khách hàng gói đầu tiên	trực tiếp giữa gia đình - Chuyên viên - Điều phối viên; tư vấn cá nhân hóa lựa chọn gói (An tâm/Đồng hành/Phục hồi) dựa trên hồ sơ nhu cầu đã khảo sát	chạm trực tiếp tại nhà	- Tỷ lệ chuyển từ tư vấn sang dùng thử
4. Lan tỏa	Tháng 4-6	GD3 - GD4: Vận hành → Đánh giá	Giữ chân khách hàng hiện tại, biến họ thành nguồn giới thiệu, đồng thời tích lũy dữ liệu định tính phục vụ đợt đánh giá cuối kỳ thí điểm	- Khảo sát hài lòng định kỳ, thu thập câu chuyện thật (với sự đồng ý của khách hàng) - Chương trình giới thiệu bạn bè với ưu đãi hai chiều - Thử nghiệm tiếp cận kênh B2B - giới thiệu gói phúc lợi hỗ trợ cha mẹ nhân viên tới một số doanh nghiệp gần khu vực thí điểm	Ứng dụng/ Bảng quản lý chăm sóc gia đình, nhóm cộng đồng khách hàng, chương trình referral	- Tỷ lệ gia hạn/nâng cấp gói - Tỷ lệ khách hàng mới đến từ giới thiệu - Mức độ hài lòng của khách hàng qua khảo sát

Bảng 10: Kế hoạch truyền thông tích hợp

Nhóm nghiên cứu cần đảm bảo các Kênh truyền thông sau sẽ hoạt động liên tục xuyên suốt cả 4 giai đoạn:

- Zalo OA/hotline chăm sóc khách hàng: Điểm chạm phản hồi nhanh cho cả khách hàng tiềm năng lẫn khách hàng hiện tại.
- Quan hệ với Hội Người cao tuổi và các trạm y tế phường: Vừa đóng vai trò làm kênh tiếp cận, vừa là nguồn bảo chứng uy tín tại địa phương, cần được duy trì liên tục thay vì chỉ khai thác ở giai đoạn đầu.
- Fanpage/Website: Duy trì nhịp nội dung giáo dục thị trường đều đặn để tiếp tục nuôi dưỡng nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển đổi ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **bTaskee.** (n.d.). *Chăm sóc người cao tuổi - bCare*.
<https://www.btaskee.com/vi-VN/cham-soc-nguoi-cao-tuoi/>
2. **Bộ Y tế & Nhóm Đối tác Y tế (HPG).** (2018). *Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2016: Hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam*. Nhà xuất bản Y học.
3. **General Statistics Office of Vietnam.** (2025a, January). *Thông cáo báo chí kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024*.
<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/01/thong-cao-bao-chi-ket-qua-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-giua-ky-nam-2024/>
4. **General Statistics Office of Vietnam.** (2025b, December). *Di cư nội địa Việt Nam giai đoạn 2009–2024*.
<https://www.nso.gov.vn/default/2025/12/di-cu-noi-dia-viet-nam-giai-doan-2009-2024/>
5. **Kamei, T., Kawada, A., Minami, K., Takahashi, Z., Yamamoto, Y., Suzuki, Y., Watanabe, T., et al.** (2024). Effectiveness of an interdisciplinary home care approach for older adults with chronic conditions: A systematic review and meta-analysis. *Geriatrics & Gerontology International*, 24(9), 827–840.
<https://doi.org/10.1111/ggi.14931>
6. **Larson, E. W., & Gray, C. F.** (2020). *Project management: The managerial process* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
7. **Phí, M. P., & Phí, M. H.** (2022). Nhu cầu chăm sóc dài hạn của người cao tuổi ở Việt Nam: Bằng chứng từ khảo sát quốc gia. *Tạp chí Kinh tế và Phát triển*, (442).
8. **Quốc hội.** (2009). *Luật Người cao tuổi* (Luật số 39/2009/QH12). Văn phòng Chính phủ.
<https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=92321&pageid=27160&typegroupid=3>
9. **Quốc hội.** (2025). *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân* (Luật số 91/2025/QH15). Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Văn bản Pháp luật.
<https://vbpl.vn/hanoi/Pages/vbpq-thuoc tinh.aspx?ItemID=179252&Keyword=&>
10. **Quốc hội Việt Nam.** (2019). *Bộ luật Lao động* (Bộ luật số 45/2019/QH14). Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
11. **Tổng cục Thống kê.** (2024). *Kết quả chủ yếu một số chỉ tiêu chính của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024*.

12. **Tổng cục Thống kê, Quỹ Phát triển Đô thị Nhật Bản, & Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc.** (2021). *Người cao tuổi ở Việt Nam: Phân tích từ Điều tra Biến động Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình năm 2021*. Nhà xuất bản Trẻ.
13. **World Health Organization.** (2018). *Integrated care for older people (ICOPE): Realigning primary health care to respond to population ageing*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.44>